

On a la vessie et on a l'insertion ici au niveau de ce tubercule de Muller, au niveau du sinus urogenital. On a la portion ici de la vessie, l'urètre et puis la tâche au niveau du vagin. Ça c'est du mésoderme puisque c'est du canal de Muller. C'est de l'âme vaginale par la croissance postérieure du sacrum et du tube neural. La vitesse de croissance différentielle par rapport à cette partie-ci va donner cet espace d'ouverture pour le vagin. C'est de nouveau la partie postérieure par rapport à mon rein, entre les deux, qui crée cet espace dans sa croissance. Avec le tubercule de Muller qui vient se mettre ici, il y a une attache qui se fait ici. La croissance différentielle postérieure, c'est-à-dire que le tubercule... Le tubercule de Muller ici va s'épaissir. Il s'épaissit et puis il va être étiré. Mais ce n'est pas qu'il est étiré, c'est que c'est la partie postérieure qui pousse plus vite et qui donne cette espèce d'allongement pour former le vagin qui sera ici et le col de l'utérus. Donc la paroi postérieure du sinus urogenital va s'épaissir ici. Ça va former petit à petit ici les lames vaginales. Elles vont s'ouvrir et s'étirer. C'est la même dynamique. C'est la partie postérieure qui va grandir beaucoup plus vite ici. C'est à la fois ceci et ceci qui se passe par rapport à deux mouvements. Ça veut dire que quand on travaille sur un utérus, j'ai le sacrum et entre les deux, j'ai cette espèce de mouvement au niveau du péritoine. C'est très simple ce que vous faites, mais sauf que là, vous avez le sens et l'idée de ce qui se passe. C'est dans ces deux-là que je vais avoir... à la fois tout l'équilibre vaginal, tout l'équilibre utérin. Au niveau gonadique, par contre, je mets l'inverse, je me mets au niveau du ventre. Ce sera un mouvement où je vais suivre le ligament. Et donc, en fait, c'est un mouvement comme ceci vers le pubis. C'est une vague qui descend comme ceci. la descente du sacrum par mon tube neural. Et ici, j'ai un autre point d'appui, c'est la combinaison, j'exagère le mouvement, c'est ceci. Si je retire, c'est ceci. Ça, c'est tout un équilibre de pile pubis ici, où j'ai l'équilibre facial au niveau du petit bassin chez la

femme. Là, j'ai un autre point, n'oubliez pas, important. La ligne est ici, la ligne de force, comme ceci. C'est un mouvement descendant relatif par rapport à mon sacrum, de nouveau. La femme a fréquemment fait des fausses couches. Ça donne une trace, parce que ça a été mis dans l'utérus. Il faut nettoyer l'utérus sur un plan énergétique. Quand on prend le côté utérus, on peut le prendre avec une certaine force au niveau magnétique. Il faut apprendre à ressentir. On se met légèrement à distance. On peut petit à petit, jusqu'à un moment donné, quand je viens ici, là, il y a une fréquence qui se met. Petit à petit, elle peut même ressentir. Elle peut commencer à sentir une zone de chaleur qui va se densifier. Moi, je travaille comme ça, si c'est nécessaire. Là, je vais scanner, je vais sentir s'il y a des choses qu'il faut nettoyer ou pas. Tu peux simplement enlever la parole, tu peux guider, tu dois absolument redonner une liberté. Par exemple, je ressens quelque chose qui va s'exprimer ici. Non, non, je suis sur son champ électrique. L'utérus normal est ici. Et puis, ça, c'est une rétroversion totale et vous avez différents degrés. Mais en sachant que ceci provoque ce qu'on appelle des phases congestives. La seule chose que je fais, je fais un travail à distance et je rééquilibre le système gynécologique, qui est très important par rapport à la gastrine. Il y a aussi ce qu'on appelle l'endométriase, une prolifération qui remonte dans le péritoine. Ça donne fréquemment des douleurs lombaires et sa croûte qui est importante. Chez la femme, il y a un lien qui est direct avec, via le col de l'utérus, via les trompes, avec la cavité intra-péritoneale. C'est un lieu important, cette cavité intra-péritoneale, parce que c'est la première cavité, c'est le ciel. Chaque état est la meilleure réponse fonctionnelle possible. Mais en fonction de ta vie, de ta propre vie et de la vie de tes ancêtres, tu portes la meilleure réponse possible dans un moment. Et si c'est nécessaire que tu aies une rétroversion, peut-être que c'est la meilleure réponse que tu as par rapport à

quelque chose que tu dois résoudre. Ce qu'il faut c'est essayer de comprendre pourquoi tu portes un schéma transgénérationnel en toi, qui t'a amené à avoir cette meilleure réponse. Parfois c'est la meilleure réponse qui t'a amené à avoir cette meilleure réponse. Parfois c'est la meilleure réponse qui t'a amené à avoir cette meilleure réponse. Mais c'est nécessaire peut-être de ne pas avoir une enfant. Il y a quelque chose de trop loin qui n'est pas résolu, tu vois. Donc c'est peut-être une réponse, tu vois, ou c'est peut-être une autre réponse plus subtile. C'est toujours la meilleure possibilité qu'on va trouver dans sa réponse. Et c'est à nous d'avoir le bon décodage et la bonne formulation, si c'est nécessaire, si c'est demandé, à pouvoir donner la libération, tu vois. Parce que les gens viennent rechercher le point où ils peuvent être libérés. des gens qui viennent si tu le reconnais pas, tu le verras peut-être une fois, puis ils partiront. L'embryon nous montre qu'à chaque stade de développement, il a toujours la meilleure réponse physiologique dans son développement. Le tube neural ici et derrière il y a ce qu'on appelle une éminence caudale et il va y avoir comme une lumière un espace qui va s'ouvrir et connexion. On voit le bourgeon caudal, la partie terminale de la notochorde. J'ai l'espace du rectum et puis j'ai le tube neural ici tu vois avec le neuroport postérieur. Et bien il va y avoir une connexion qui va se faire par rapport à tout ce mouvement développemental qui est beaucoup plus important à la partie postérieure que la partie antérieure, avec la fermeture ici et une réouverture ici pour donner cette connexion. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec une vitesse, avec un point d'appui qu'on va appeler ici l'émergence de mon neuroport postérieur qui est ici et puis l'allongement pour former mon phylum terminal. Et ça, ça va former ce qu'on va appeler la neurulation secondaire. Quand je prends le sacrum en main, ça vous donne une nouvelle information. On voit de nouveau que c'est des vitesses de croissance, tu vois, différentielles avec le point d'appui qui est juste ici

par rapport à mon sacrum qui se développe. Au départ, cette jonction ici est déjà là. Et puis c'est un allongement postérieur avec l'intégration de cette éminence caudale pour former la continuité avec le tube neural et former ce qu'on appelle cette neurulation secondaire ascendante. Au niveau du périnée, je vais avoir ici l'émergence de mes membres inférieurs. J'ai une traction qui se fait ici. Ce mouvement avec le système utérin est très important. C'est un mouvement qui est très, Et la bascule du foie ici par rapport à ce mouvement-là ramène, tu vois, avec la descente ici de mon tube neural, le sacrum, le mouvement ici de développement qui va se tirer vers la ligne blanche avec le ligament falciforme, tu vois, qui vient tirer, ça va donner et ce développement hépatite qui vient se faire comme ceci, comme ceci, tu vois, va ramener cette bascule et ramène toute la zone utérine qui se développe. par cette voie, par ici, et qui pourrait expliquer peut-être des phénomènes de migration, de traction différentielle par rapport au système hépatique, par rapport à la position utérine. Il y a une espèce de ligament qui se développe ici, entre le pubis et l'ombilique, qui contient toute l'histoire de ta descente et de ta formation utérine. La concentration dans le tissu de ça, comme le sternum, contient aussi une histoire de ta flexion. Là, ça contient une histoire de toute ta formation postérieure et de la gonadisation et de l'utérisation du bassin. Le ligament ventromédial ici, sur la ligne blanche. Et cette ligne blanche, c'est justement la réunion de toute l'histoire urogenitale.